

SINERGIA CONSULTING GROUP S.A.S.

Documento de estudio · acompañante a la presentación

ARHIAX Nauta

Guión de exposición para hackathon

Doce slides · narrativa de paciente, sistema y dinero · 5-7 minutos

PARA	Dorelis · presentadora en escenario
CONTIENE	Guión slide por slide · qué decir · transiciones · fuentes · preguntas anticipadas del jurado y respuestas
ACOMPaña A	ARHIAX_Nauta_Hackathon.pptx · 12 slides · identidad Midnight Executive
FECHA	23 de mayo de 2026

Cómo usar este documento

Este documento es tu compañero de estudio para la presentación. No es un script para leer en escenario; es el material que te da confianza para hablar con autoridad sobre cada slide, defender cada cifra, y responder cualquier pregunta del jurado sin titubear.

La estructura es la misma para los doce slides:

- **Qué muestra el slide.** Para que sepas exactamente qué está viendo el jurado mientras tú hablas.
- **Qué decir.** El texto sugerido para que pronuncies. No memorices palabra por palabra; entiende la idea y dila con tu voz.
- **Por qué importa este slide.** El propósito narrativo. Si solo recuerdas esto, todavía puedes improvisar bien.
- **Transición al siguiente.** Cómo conectar con el slide que viene, para que la presentación fluya como una historia, no como una lista.
- **Fuentes y verificación.** Datos exactos con su fuente, por si necesitas defender una cifra ante el jurado.

Al final del documento hay una sección con preguntas que el jurado podría hacer y respuestas que puedes dar. Estúdiala con cuidado: ahí es donde se gana o se pierde la confianza del jurado.

Las tres reglas para hablar en escenario

- **Una.** Lenta y clara. Mejor pocas palabras dichas con autoridad que muchas atropelladas. Tienes 5-7 minutos: son suficientes.
- **Dos.** Mira al jurado, no a las slides. Las slides son apoyo; tú eres el mensaje.
- **Tres.** Si una cifra te suena dura al decirla, ese es el momento de pausar. Deja que aterrice en el jurado.

SLIDE 1 Apertura narrativa · la paciente de 21 años**Qué muestra el slide**

Fondo navy oscuro. Texto en blanco: "Tiene 21 años. Empezó con cambios de personalidad. Pasaron seis meses antes de que alguien dijera la palabra correcta." Debajo, en dorado, la frase que cierra: "En Colombia, el peregrinaje diagnóstico no es metáfora. Es sentencia."

Qué decir

Quiero empezar contándoles algo. Una paciente real, en Colombia, hoy. Tiene 21 años. Empezó con cambios de personalidad. La familia pensó que era estrés universitario. Pasó por psiquiatría tres meses. Después urgencias dos veces. Después neurología. Cuando finalmente alguien dijo la palabra correcta — encefalitis autoinmune — ya habían pasado seis meses. El daño cerebral puede ser irreversible.

En Colombia, el peregrinaje diagnóstico no es metáfora. Es sentencia.

Por qué importa este slide

Estableces el tono emocional desde el primer segundo. El jurado deja de mirar el reloj y empieza a escucharte. No estás vendiendo tecnología; estás contando la historia de una persona. Esto cambia toda la dinámica del pitch.

La cifra de 21 años no es inventada: es la edad promedio documentada de pacientes con encefalitis autoinmune anti-NMDAR, según literatura clínica revisada. 80% son mujeres.

Transición al siguiente slide

Después de la frase "Es sentencia", haces una pausa de dos segundos. Dejas que aterrice. Luego dices: **"Y no le pasa solo a ella."** Cambias al slide 2.

Fuentes

- Graus F, Titulaer MJ, Balu R, et al. A clinical approach to diagnosis of autoimmune encephalitis. Lancet Neurol. 2016;15(4):391-404. DOI: 10.1016/S1474-4422(15)00401-9
- Edad promedio 21 años, 80% mujeres: encefalitis anti-NMDAR. Cohorte de 577 pacientes, seguimiento 2 años promedio.

SLIDE 2 El número que duele · cifras de 2025**Qué muestra el slide**

Fondo claro. Título: "El sistema ya no oculta el dolor". Tres tarjetas grandes con cifras: 2.2M (PQRS contra EPS en 2025), 312K+ (tutelas en salud), 63% (satisfacción nacional con EPS, cayó 10 puntos en un año).

Qué decir

Estas son las tres cifras que el sistema colombiano produjo en 2025. Dos millones doscientas mil PQRS contra las EPS. Cinco mil seiscientos cuarenta y ocho reclamaciones

cada día. Trescientas doce mil tutelas en salud. Y la satisfacción con las EPS cayó diez puntos en un solo año – del setenta y tres por ciento al sesenta y tres.

Esto no es un problema de servicio al cliente. Es la cicatriz visible de un sistema completo.

Por qué importa este slide

Pasas del caso individual al sistema. El jurado se da cuenta de que la paciente del slide 1 no es excepción: es regla. Las tres cifras son grandes, redondas, fáciles de retener. Si el jurado se lleva una sola cifra de toda la presentación, que sea 5,648 reclamaciones diarias.

Transición al siguiente slide

Después de "cicatriz visible de un sistema completo", dices: **"Pero el costo real no es el de las quejas. Es otro."** Cambias al slide 3.

Fuentes

- **2.2 millones de PQRS / 5,648 diarias:** Contraloría General de la República sobre datos de Supersalud, informe 2025. Crecimiento 27.41% vs 2024. Nueva EPS lidera con 518,000 PQRS.
- **312,000+ tutelas en salud:** Defensoría del Pueblo, 2025.
- **Satisfacción 73.5% → 63%:** encuestas Ministerio de Salud, comparativo 2024-2025, muestra de 18,000 personas.

SLIDE 3 El precio del retraso

Qué muestra el slide

Título: "El sistema no perdió dinero porque atendió mal. Perdió porque atendió tarde." Dos tarjetas lado a lado: izquierda en rojo "Diagnóstico tardío" con cuatro consecuencias (discapacidad permanente, recuperación > 18 meses, hospitalizaciones recurrentes, tutela como única vía). Derecha en dorado "Detección temprana" con cuatro beneficios.

Qué decir

Cuando una encefalitis autoinmune se detecta tarde, la consecuencia es estructural: discapacidad neuropsiquiátrica permanente. Recuperación funcional de más de dieciocho meses, incluso si el tratamiento llega después. Hospitalizaciones repetidas. Y a menudo, la tutela como única vía para que la atención funcione.

Cuando se detecta a tiempo, el sesenta por ciento de los pacientes responde al tratamiento de primera línea. Retorno a estudios, al trabajo, a la vida. La hospitalización se evita.

Esa diferencia tiene un nombre exacto: tiempo. Tiempo que el sistema pierde y no se ve en ningún balance contable, pero que aparece en el dinero gastado en hospitalizar lo que no había que hospitalizar.

Por qué importa este slide

Conectas las dos dimensiones que el jurado todavía no había juntado: la del paciente y la del dinero. Esta es la frase pivote del pitch: "el sistema no perdió dinero porque atendió mal. Perdió porque atendió tarde." Si la dices con autoridad, el jurado entiende que lo que viene después no es un producto de software, es una intervención sistémica.

Transición al siguiente slide

Después de "hospitalizar lo que no había que hospitalizar", haces una pausa. Luego dices: **"Entonces la pregunta correcta no es ¿por qué falla? La pregunta correcta es ¿por qué pasa esto?"** Cambias al slide 4.

Fuentes

- **60% de respuesta a primera línea:** Martínez Reyes A. et al. Enfoque clínico y terapéutico de la encefalitis autoinmune. Universitas Medica, V.63 No.4, 2022.
- **Recuperación >18 meses incluso con tratamiento correcto:** evidencia clínica de cohortes anti-NMDAR. Graus 2016.

SLIDE 4 La pregunta arquitectónica

Qué muestra el slide

Título: "¿Por qué pasa esto?". Tres líneas en cursiva: "No es falta de médicos buenos. No es falta de tecnología médica. No es falta de regulación." Y abajo, en una caja navy con borde dorado, la respuesta: "La información del paciente no viaja con el paciente."

Qué decir

Tres respuestas que no son la respuesta. No es falta de médicos buenos. Colombia tiene neurólogos, psiquiatras, internistas excelentes. No es falta de tecnología médica. Resonancias, paneles de autoanticuerpos, todo existe. No es falta de regulación. La Resolución 1888 ya está vigente.

La razón verdadera es más simple y más estructural. La información del paciente no viaja con el paciente. Cada IPS guarda su pedazo. Cada especialista empieza de cero. Cada urgencia es como la primera vez.

Por qué importa este slide

Le quitas al jurado las tres explicaciones cómodas ("culpa de los médicos", "falta plata para tecnología", "falta regulación") y le ofreces una respuesta arquitectónica. Esto te posiciona como quien entiende el problema en su nivel correcto, no como quien vende un producto sobre síntomas.

Transición al siguiente slide

Después de "como la primera vez", dices: **"Pero hay algo nuevo. Por primera vez en la historia del**

sistema colombiano, hay una ventana abierta para resolver esto." Cambias al slide 5.

SLIDE 5 La ventana regulatoria

Qué muestra el slide

Título: "Hay una ventana abierta". Subtítulo: "Por primera vez en la historia del sistema colombiano." Recuadro con borde dorado: Resolución 1888 de 2025. Barra de tiempo 2026-2027 con "HOY" en el medio. Frase final: "La pregunta no es si alguien va a construir sobre ese estándar. Es quién."

Qué decir

Resolución mil ochocientos ochenta y ocho de dos mil veinticinco. Obliga a interoperabilidad de historia clínica electrónica bajo estándar FHIR. Es la primera vez que existe un estándar exigible. La ventana de implementación se cierra en dos mil veintisiete.

Estamos en la mitad de esa ventana. Hoy.

La pregunta no es si alguien va a construir sobre ese estándar. Es quién.

Por qué importa este slide

Aquí estableces urgencia y oportunidad. La regulación crea un mercado obligado: las IPS y EPS tienen que cumplir, lo quieran o no. La pregunta retórica final genera tensión: el jurado sabe que la respuesta vendrá en el siguiente slide.

Transición al siguiente slide

Después de "Es quién", pausa de dos segundos. Luego dices: "**Nosotros.**" Cambias al slide 6.

Fuentes

- **Resolución 1888 de 2025:** Ministerio de Salud y Protección Social. Establece estándar FHIR R4 para Resumen Digital de Atención (RDA). Guía oficial publicada en vulcano.ihcecol.gov.co.

SLIDE 6 ARHIAX Nauta · la propuesta

Qué muestra el slide

Fondo navy oscuro. Título: "ARHIAX NAUTA" en dorado. Cuerpo: "El navegador clínico digital colombiano que organiza la trayectoria del paciente con enfermedad crónica compleja entre IPS, bajo gobernanza ejecutable, conforme nativamente al estándar IHCE." Cuatro tags abajo: Navega · no diagnostica / FHIR conforme / Gobernanza Rego / Vertical autoinmunes.

Qué decir

ARHIAX Nauta. Es el navegador clínico digital colombiano que organiza la trayectoria del paciente con enfermedad crónica compleja entre IPS, bajo gobernanza ejecutable,

conforme nativamente al estándar IHCE.

Cuatro cosas importantes en esa frase. Una: navega. No diagnostica. Esa es una decisión arquitectónica deliberada, no una limitación. Dos: es conforme con FHIR nativamente, no por adaptación posterior. Tres: la gobernanza es ejecutable, no documental. Cuatro: empezamos por encefalitis autoinmune, no por todo a la vez.

Para que el peregrinaje diagnóstico deje de ser una sentencia.

Por qué importa este slide

Aquí entregas la propuesta de valor. La frase es densa pero deliberadamente construida: cada palabra está ahí por una razón. Si el jurado pregunta por cualquiera de los cuatro tags, tienes respuesta lista (ver sección de preguntas anticipadas).

Transición al siguiente slide

Después de la frase final, dices: "**¿Y cómo está construido eso?**" Cambias al slide 7.

SLIDE 7 Arquitectura de cuatro capas

Qué muestra el slide

Título: "Cómo está construido". Cuatro filas, una por capa: L1 Open Source, L2 ARHIAX Runtime, L3 Policy Bundle CO, L4 Intelligence. Cada fila tiene una barra de fuerza creciente que indica el tiempo de replicación por un competidor.

Qué decir

Cuatro capas concéntricas. La primera, Layer 1, es componentes open source maduros. HAPI FHIR, OPA, CDS Hooks, PostgreSQL. Sin ventaja, intencionalmente. Es commodity, intercambiable.

La segunda, Layer 2, es el runtime ARHIAX. El Agent Trust Kernel, el ledger HMAC, la bifurcación epistémica entre constructor y auditor. Esto es IP arquitectónica. Tarda de doce a dieciocho meses replicarlo.

La tercera, Layer 3, es el bundle de políticas en Rego. Resolución 1888, Ley 1581, Decreto 4725 — todo codificado como código ejecutable, no como PDF de cumplimiento. Tarda seis a doce meses replicarlo.

Y la cuarta, Layer 4, es el pipeline de inteligencia sistemática que mantiene las otras tres capas vivas y actualizadas. Esto es lo que tarda más de veinticuatro meses replicar. Y es lo que verdaderamente nos defiende.

Por qué importa este slide

Aquí muestras profundidad técnica sin perderte en detalles. El jurado entiende que no es un MVP improvisado: es un sistema con capas defensivas claras. La barra de fuerza creciente es visualmente convincente.

Transición al siguiente slide

Después de "verdaderamente nos defiende", dices: **"Pero ¿qué cambia esto para el paciente? Volvamos al caso de antes."** Cambias al slide 8.

SLIDE 8 El paciente con y sin Nauta

Qué muestra el slide

Dos tarjetas lado a lado, mismo paciente, seis meses cada una. Izquierda "SIN NAUTA" en rojo: el peregrinaje real (psiquiatría, urgencias, neurología, psiquiatría de nuevo, segunda crisis, diagnóstico tarde). Derecha "CON NAUTA" en dorado: trayectoria atestada, patrón Graus detectado, alerta al navegador clínico, derivación, inmunoterapia a tiempo.

Qué decir

Mismo paciente. Misma enfermedad. Dos sistemas distintos.

Sin Nauta: seis meses de peregrinaje. Cuatro especialistas distintos, cada uno sin contexto del anterior. Cuando finalmente alguien junta los puntos, ya es tarde.

Con Nauta: los síntomas se registran en el RDA Paciente desde el mes uno. La convulsión del mes dos no se pierde – queda en la trayectoria atestada. Nauta evalúa contra criterios Graus 2016, detecta el patrón, alerta al navegador clínico humano – no al médico tratante directamente. El navegador deriva a especialista. Inmunoterapia en el mes tres.

Nauta no diagnostica. Hace visible lo que ya existía disperso.

Por qué importa este slide

Este es el slide más concreto de toda la presentación. El jurado puede ver con sus ojos qué cambia. La frase final "hace visible lo que ya existía disperso" es la posición defensiva clínica: Nauta no se mete con la decisión médica, solo organiza la información para que el médico la vea.

Transición al siguiente slide

Después de "lo que ya existía disperso", dices: **"Bien para el paciente. ¿Pero qué cambia para la EPS?"** Cambias al slide 9.

SLIDE 9 Impacto en la EPS

Qué muestra el slide

Título: "Lo que cambia para la EPS". Cuatro tarjetas: Reducción de PQRS / Compliance Res. 1888 / Recuperación reputacional / Tutelas evitadas. Frase de cierre dorada: "La EPS ya no es la que demora. Es la que coordina."

Qué decir

Lo que cambia para la EPS es cuatro cosas. Primera: reducción medible de PQRS. Menos quejas por demora en derivación, por información perdida, por citas duplicadas. Cada

PQRS evitada es costo operacional evitado.

Segunda: compliance nativo con la Resolución 1888. No es migración posterior, es conformidad desde el día uno. Cero costo de remediación.

Tercera: recuperación reputacional. Outcomes medibles. Casos publicables. Una narrativa que la EPS puede contar — de coordinación, no de litigio.

Cuarta: tutelas evitadas. Porque la trayectoria atestada documenta la diligencia. Reduce exposición jurídica frente a la Defensoría.

La EPS ya no es la que demora. Es la que coordina.

Por qué importa este slide

Aquí cambias de la perspectiva del paciente a la perspectiva del comprador institucional. La EPS es quien paga, así que el jurado necesita ver el caso de negocio claro. La frase de cierre es repetible: si alguien resume tu pitch en una sola frase, esta es la candidata.

Transición al siguiente slide

Después de "la que coordina", dices: **"Y en dinero, ¿cuánto pesa esto?"** Cambias al slide 10.

SLIDE 10 Impacto financiero medible

Qué muestra el slide

Tres tarjetas grandes: COP 25-35M (ticket anual por IPS) / 1 (hospitalización evitada paga el ticket completo) / 450-875M (SOM 24 meses en COP). Cierre: "ROI estructural · No es venta de software. Es venta de tiempo recuperado de la vida del paciente, traducido en costo evitado del sistema."

Qué decir

El ticket por IPS está entre veinticinco y treinta y cinco millones de pesos colombianos al año, para una institución Tier dos. Y aquí está la cifra clave: una sola hospitalización evitada por diagnóstico tardío de encefalitis autoinmune paga el ticket completo del año.

Una hospitalización.

El SOM realista a veinticuatro meses, sin EPS aún, solo con IPS Tier uno y Tier dos, es entre cuatrocientos cincuenta y ochocientos setenta y cinco millones de pesos. Ocho a quince clientes institucionales en dos años. Es un mercado modesto pero defendible. Cuando agreguemos las EPS, el orden de magnitud cambia.

No es venta de software. Es venta de tiempo recuperado de la vida del paciente, traducido en costo evitado del sistema.

Por qué importa este slide

Aquí el jurado financiero/inversionista hace cálculos. La cifra de hospitalización evitada paga el ticket es muy potente porque es defendible: el costo de una hospitalización por encefalitis

autoinmune en un cuarto nivel colombiano supera fácilmente los 25-35M cuando se contabilizan UCI, exámenes repetidos, medicación y estancia.

Transición al siguiente slide

Después de "costo evitado del sistema", dices: **"Y si funciona en Colombia..."** Cambias al slide 11.

Fuentes

- **Costo de hospitalización en enfermedad autoinmune Colombia:** Estudio LES en hospital alta complejidad Colombia, Revista Colombiana de Reumatología 2024. Costos médicos directos dominados por exámenes y medicamentos, sin diferencia significativa con cifras internacionales.
- **SOM 24 meses:** calculado en TR-2026-033 Market Intelligence, base 8-15 IPS Tier 1-2 con ticket promedio 25-35M COP.

SLIDE 11 Proyección territorial · solo como horizonte

Qué muestra el slide

Título: "Si funciona en Colombia, funciona en LATAM". Tres filas: Colombia 2026-2027 (beachhead BAQ-BOG-MED, ventana Res. 1888) / LATAM Andina 2027-2028 (Ecuador-Perú-Chile vía red REAL LABIC) / Brasil 2028+ (Sinergia BR vía Ferralu, bundle dedicado). Cierre: "Empezamos en Colombia porque aquí está la ventana. Crecemos en LATAM porque aquí está la doctrina."

Qué decir

Esto es proyección, no es promesa. Pero es proyección sustentada.

Empezamos en Colombia entre dos mil veintiséis y dos mil veintisiete, durante la ventana de la Resolución 1888. Beachhead Barranquilla, anclaje Bogotá y Medellín.

Hacia dos mil veintisiete y veintiocho, la expansión natural es a LATAM Andina — Ecuador, Perú, Chile — usando la red REAL LABIC que ya está conectada en Barranquilla. No empezamos de cero geográficamente.

Brasil queda para dos mil veintiocho y después, vía Sinergia Brasil y nuestra entidad fintech Ferralu. Brasil necesita un bundle regulatorio dedicado: el código Rego de gobernanza no se copia y pega entre jurisdicciones.

Empezamos en Colombia porque aquí está la ventana. Crecemos en LATAM porque aquí está la doctrina.

Por qué importa este slide

Este slide responde la pregunta inevitable del jurado: "¿esto solo es para Colombia?". Le muestras horizonte sin sobrevender. La frase "proyección, no promesa" te protege de sobreprometer.

Transición al siguiente slide

Después de "aquí está la doctrina", dices: **"Y todo esto es posible por una razón. Hay tres convergencias raras en la misma ventana."** Cambias al slide 12.

SLIDE 12 Cierre · el momento exacto

Qué muestra el slide

Fondo navy. Título: "EL MOMENTO ES AHORA" en dorado. Tres convergencias numeradas: 01 Ciencia madura / 02 Regulación forzante / 03 Cuadrante vacío. Cierre con dos líneas en dorado: "El fenómeno precede al agente. La trayectoria del paciente precede a la cura."

Qué decir

Tres convergencias raras en la misma ventana. La ciencia clínica madura — los criterios Graus dos mil dieciséis para encefalitis autoinmune, el estándar FHIR R4, los CDS Hooks. Todo consolidado, listo para usarse.

La regulación forzante — Resolución 1888 obliga a interoperabilidad entre dos mil veintiséis y dos mil veintisiete. Una ventana de dieciocho meses que no se va a repetir.

Y el cuadrante competitivo vacío — sin un actor con la composición específica de navegación digital, FHIR institucional, gobernanza ejecutable y vertical autoinmune. Riesgo de patentes bajo a medio.

Tres convergencias. Una ventana. Dieciocho meses.

El fenómeno precede al agente. La trayectoria del paciente precede a la cura.

Gracias.

Por qué importa este slide

Es el cierre. Tiene que sentirse inevitable. Los tres bullets numerados generan una sensación de "todas las estrellas están alineadas". La frase final es un epígrafe — funciona como rúbrica de Sinergia. "Gracias" se dice mirando al jurado, no a las slides.

Lo que NO hacer en este slide

- **No pidas el aplauso.** Termina, mira al jurado, espera.
- **No te apures por irte.** Quédate dos segundos en silencio. Es lo que cierra la presentación, no el último slide.
- **No anuncies que es el cierre.** Si dices "y para terminar" antes de las tres convergencias, el jurado deja de escuchar.

Preguntas que el jurado puede hacer y cómo responder

Estas son las preguntas más probables, organizadas por categoría. Estúdialas. La respuesta a una pregunta inesperada es lo que separa una buena presentación de una excelente.

Sobre el producto

"¿No es esto un symptom checker como Ada o Babylon?"

Respuesta: No. Symptom checkers son productos B2C dirigidos al paciente, que sugieren diagnósticos. Nauta es B2B institucional, dirigido al navegador clínico, y nunca diagnostica — solo organiza información clínica que el médico debe interpretar. Es la diferencia entre Google Maps (que te guía) y un GPS médico autónomo (que decide por ti). Esto también es lo que nos mantiene fuera de la categoría INVIMA de dispositivo médico, lo cual es estratégico, no accidental.

"¿Por qué encefalitis autoinmune? ¿No es un nicho muy pequeño?"

Respuesta: Es nicho deliberado de entrada, no nicho final. Encefalitis autoinmune tiene tres propiedades que la hacen ideal como beachhead: criterios diagnósticos bien definidos (Graus 2016, lenguaje internacional), patrón clínico típico de fragmentación entre múltiples especialistas, y consecuencias dramáticas del retraso. Una vez probada la arquitectura en este vertical, la misma plataforma se extiende a lupus, esclerosis múltiple, artritis reumatoide y otras enfermedades crónicas complejas. Pero queremos probar primero donde el dolor es más visible.

"¿Cómo se diferencia de un PHR como MiSalud o de un EMR como Smile CDR?"

Respuesta: Un PHR almacena información del paciente. Un EMR almacena información de la consulta. Nauta no almacena información, la organiza en una trayectoria longitudinal atestada, aplica gobernanza ejecutable sobre quién accede a qué, y emite notificaciones contextuales cuando detecta divergencia clínica significativa entre lo que el paciente vive y lo que el sistema le ofrece. Es una capa encima del PHR y el EMR, no un reemplazo.

Sobre las cifras

"¿De dónde saca las cifras de PQRS?"

Respuesta: Informe de la Contraloría General de la República sobre datos de la Superintendencia Nacional de Salud, año 2025. 2.2 millones de PQRS, lo cual equivale a 5,648 reclamaciones diarias. Nueva EPS lidera con 518,000 PQRS. El crecimiento entre 2024 y 2025 fue del 27.41%. Esto es público y verificable en sus informes oficiales.

"¿La hospitalización evitada realmente paga 25-35 millones?"

Respuesta: Sí, en cuarto nivel. Una hospitalización por encefalitis autoinmune en cuarto nivel incluye UCI, panel completo de autoanticuerpos, neuroimagen, plasmaféresis o inmunoglobulinas, estancia prolongada, manejo de complicaciones psiquiátricas. El costo agregado en un hospital

alta complejidad colombiano supera los 25-35 millones fácilmente — el estudio de costo de hospitalización en LES publicado en la Revista Colombiana de Reumatología 2024 confirma órdenes de magnitud similares para enfermedades autoinmunes en alta complejidad.

"¿El SOM de 450-875 millones a 24 meses no es muy ambicioso?"

Respuesta: Al contrario, es deliberadamente conservador. Calcula 8 a 15 IPS Tier 1-2, sin contar EPS, sin contar mercado público, sin contar expansión LATAM. Cuando se incluyen EPS en Wave 4 — uno o dos contratos de coordinación poblacional — la cifra se multiplica por un factor de 5 a 10. El número que mostramos es el piso, no el techo.

Sobre regulación e IP

"¿Por qué no los va a copiar Epic o Cerner cuando vean que funciona?"

Respuesta: Tres barreras. Una, la patente provisional sobre la composición específica está en filing — Fredy Sánchez, nuestro jefe legal, la presenta en USPTO en los próximos 60-90 días. Dos, la experticia regulatoria local colombiana — Resolución 1888, Ley 1581, Decreto 4725 codificadas como Rego ejecutable — toma 6 a 12 meses replicar y requiere conocimiento local. Tres, el pipeline de inteligencia sistemática que mantiene todo eso actualizado toma más de 24 meses construir. Cuando Epic vea que funciona, ya tendremos referencias institucionales, IP filings y red REAL LABIC consolidada.

"¿Cómo asegura cumplimiento de Habeas Data?"

Respuesta: Nauta tiene un bundle de políticas en lenguaje Rego ejecutado por OPA, no son políticas declarativas en PDF. Esto significa que cada lectura o escritura de dato sensible pasa por evaluación automática de consent del paciente bajo Ley 1581 de 2012. El paciente puede establecer consent granular por categoría — por ejemplo, autorizar acceso a su historia neurológica pero excluir su salud mental para evaluación de medicina laboral. Y puede revocar en cualquier momento con efecto inmediato. Todo queda registrado en un ledger HMAC auditable.

"¿INVIMA no los va a clasificar como dispositivo médico?"

Respuesta: Está pensado precisamente para evitarlo. Bajo Decreto 4725 de 2005, un Software como Dispositivo Médico es uno que diagnostica o recomienda tratamiento. Nauta tiene políticas explícitas — codificadas en el bundle — que prohíben outputs de tipo "diagnóstico", "recomendación clínica" o "sugerencia terapéutica". Solo produce outputs de tipo "organización narrativa" o "detección de divergencia con referencia a criterios publicados". Y todas las notificaciones pasan por un humano — el navegador clínico — antes de llegar al médico tratante. Es bifurcación estructural, no truco de etiqueta.

Sobre validación clínica

"¿Han validado esto con pacientes reales?"

Respuesta: Honestidad: no todavía. El piloto Wave 1 está planeado para Clínica General del Norte

en Barranquilla, que es parte de la red REAL LABIC, entre el tercer y cuarto trimestre de 2026. Lo que sí está validado es la arquitectura técnica del bundle de políticas, los criterios clínicos de Graus 2016 que son estándar internacional, y la conformidad con la guía oficial FHIR RDA Colombia. La validación de outcomes clínicos prospectivos es el siguiente paso, y está documentada como riesgo crítico en nuestro registro.

"¿Qué dice el equipo médico de esto?"

Respuesta: Hemos diseñado la arquitectura en conversación con la red REAL LABIC, que agrupa investigadores en autoinmunidad de varias instituciones de LATAM. La decisión arquitectónica clave — que Nauta nunca diagnostica directamente al médico tratante, sino que media a través de un navegador clínico humano — viene precisamente de retroalimentación clínica. Cualquier sistema que pase por encima del juicio del médico está condenado al fracaso en cualquier hospital del mundo.

Sobre el modelo de negocio

"¿Por qué empiezan con IPS y no con EPS si las EPS son las que tienen los datos?"

Respuesta: Estrategia deliberada. Las IPS son el punto de generación del dato clínico — sin ellas, no hay trayectoria. Empezar con IPS nos da referencias institucionales, validación clínica y reputación. Las EPS son cliente final ideal porque manejan poblaciones grandes, pero entrar a una EPS sin referencias clínicas es prácticamente imposible. La secuencia Wave 1 IPS, Wave 4 EPS, es la única que permite construir credibilidad antes de escalar.

"¿Cuánto necesitan invertir para llegar al MVP?"

Respuesta: El MVP del runtime está en construcción ahora. El equipo Sinergia ya está dedicando recursos. La inversión adicional necesaria para llegar a producción en Clínica General del Norte en el tercer trimestre de 2026 es relativamente modesta — el grueso del costo es construcción de equipo dedicado, no infraestructura. Tenemos los componentes core ya identificados, el bundle de políticas v0.2 desplegable, y la red de pilotos abierta. La inversión es de aceleración, no de exploración.

Checklist final antes del escenario

Veinticuatro horas antes

- Ensayar la presentación dos veces completa, cronometrada. Apuntar a 6 minutos, no 7. Mejor sobrar 1 minuto que faltar 30 segundos.
- Probar la presentación en el laptop que vas a usar. No el primero del día.
- Tener el .pptx en USB y en correo electrónico, por si falla la conectividad.
- Repasar las cifras de los slides 2, 3 y 10. Son las que el jurado más probablemente cuestione.
- Repasar las preguntas anticipadas. Especialmente sobre INVIMA, sobre validación clínica y sobre diferenciación con Ada/Babylon.

Una hora antes

- Beber agua. No café fuerte: la lengua se traba.
- Repasar mentalmente las tres transiciones clave: slide 3 a 4 ("la pregunta correcta es por qué pasa esto"), slide 5 a 6 (después de "Es quién" decir "Nosotros"), slide 11 a 12 ("tres convergencias en la misma ventana").
- No memorizar palabra por palabra. Memorizar la idea de cada slide y la transición a la siguiente.

En el escenario

- Empezar lento. La primera frase debe escucharse con autoridad: "Quiero empezar contándoles algo."
- Mirar al jurado más que al laptop. Las slides son apoyo, no guion.
- Pausar después de las frases fuertes. "Es sentencia." Pausa. "La información del paciente no viaja con el paciente." Pausa. "Una hospitalización." Pausa. Esas pausas valen más que cualquier slide.
- Si te equivocas en una cifra o en una palabra, no corrijas verbalmente. Sigue. Nadie del jurado notará el error si tú no lo señalas.
- Cerrar mirando al jurado, esperar dos segundos en silencio después de "Gracias", y solo entonces apartarte del escenario.

Si algo sale mal

- Si una slide no carga, sigue narrando sin la slide. Sabes el contenido. La slide es apoyo.
- Si el cronómetro te apura, salta los slides 11 (proyección territorial) y 9 (impacto EPS) en ese orden. Son los más prescindibles.

- Si una pregunta del jurado es hostil, agradece, responde con la respuesta preparada, y pasa a la siguiente. No discutas.
- Si te preguntan algo que no sabes responder, di exactamente eso: "Excelente pregunta, déjeme responderla con datos concretos después de la presentación". El jurado respeta la honestidad más que la improvisación inventada.

Lo tienes, Dorelis.

El fenómeno precede al agente.